PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH – HUMANIZASUS)

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 11 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

11.1 Origem e conceito

A **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (PNH)**, também chamada **HumanizaSUS**, foi lançada em **2003** pelo Ministério da Saúde. Ela não é um programa, mas uma **política transversal**, que atravessa todas as ações e instâncias do SUS. Busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços, produzindo mudanças nos modos de **gerir e cuidar**.

Humanizar, para a PNH, é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde – **usuários, trabalhadores e gestores** –, com inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. As mudanças são construídas de forma coletiva e compartilhada, e não de forma isolada.

11.2 Princípios

Princípio	Significado
Transversalidade	A PNH deve estar presente e inserida em todas as políticas e programas do SUS; amplia a comunicação entre grupos e saberes, rompendo isolamentos e hierarquias rígidas
Indissociabilidade entre atenção e gestão	As decisões da gestão interferem diretamente na atenção; trabalhadores e usuários devem conhecer e participar da gestão
Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos	Usuários e trabalhadores são protagonistas e corresponsáveis pela produção de saúde; o usuário participa das decisões sobre seu cuidado

11.3 Método

O método da PNH é o da **tríplice inclusão**: inclusão dos diferentes sujeitos (usuários, trabalhadores e gestores) na produção da saúde; inclusão dos **analisadores sociais** (fenômenos que desestabilizam modelos tradicionais e revelam tensões, como conflitos) e inclusão do **coletivo** (movimentos sociais e redes). É o chamado método da **"inclusão"** ou **"roda"** (cogestão).

11.4 Diretrizes

- **Acolhimento:** reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. É uma **postura ética**, não um local nem um horário, e deve ocorrer em todos os momentos do atendimento e por todos os profissionais. Pressupõe **escuta qualificada** e construção de vínculo. O **Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR)** organiza a fila por gravidade, e não por ordem de chegada.
- **Gestão participativa e cogestão:** inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão (colegiados gestores, rodas, conselhos, mesas de negociação permanente).
- **Ambiência:** criar espaços físicos, sociais, profissionais e de relações interpessoais **saudáveis, acolhedores e confortáveis**, que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho (iluminação, cores, cheiros, sons, arte).
- **Clínica ampliada e compartilhada:** ferramenta teórica e prática que considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença, ampliando o objeto de trabalho para além da doença; utiliza o **Projeto Terapêutico Singular (PTS)** e o apoio matricial.
- **Valorização do trabalhador:** dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão; promover saúde do trabalhador e educação permanente.

- **Defesa dos direitos dos usuários:** conhecer e cumprir os direitos dos usuários, como a **Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde** (Portaria GM/MS nº 1.820/2009), incluindo o direito a **acompanhante** e à **visita aberta**.

11.5 Dispositivos

Dispositivos são arranjos de processos de trabalho para pôr em prática as diretrizes:

- Acolhimento com classificação de risco.
- Colegiados de gestão e contratos de gestão.
- Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores (**ouvidorias**, pesquisas de satisfação).
- **Visita aberta e direito a acompanhante**.
- **Equipe de referência e apoio matricial**.
- Projeto Terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva.
- Projetos de construção coletiva da ambiência.
- Programa de Formação em Saúde do Trabalhador (PFST) e Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP).
- Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e Câmara Técnica de Humanização.
- Programas de qualidade de vida e saúde para os trabalhadores.

Equipe de referência é o grupo de profissionais responsável por determinado conjunto de usuários, criando vínculo; **apoio matricial** é o suporte técnico especializado oferecido a essas equipes (por exemplo, equipe multiprofissional apoiando a Estratégia Saúde da Família).

11.6 Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria nº 1.820/2009)

Princípios: todo cidadão tem direito ao **acesso** ordenado e organizado aos sistemas de saúde; a **tratamento adequado e efetivo**; a **atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação**; a atendimento que respeite sua pessoa, seus valores e direitos (incluindo identificação pelo **nome social**, sigilo, consentimento livre e esclarecido, acompanhante); tem **responsabilidades** para que o tratamento aconteça adequadamente; e direito ao comprometimento dos gestores para que os princípios sejam cumpridos.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- PNH lançada em 2003; é política transversal, não programa.
- Os três princípios: transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia.
- Acolhimento é postura ética, não local nem triagem.
- ACCR: atendimento por gravidade e não por ordem de chegada.
- Ambiência: espaço físico, social e de relações.
- Clínica ampliada, PTS, equipe de referência e apoio matricial.
- Direito a acompanhante e visita aberta; Carta dos Direitos dos Usuários.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"TIP"** para os princípios: Transversalidade, Indissociabilidade (atenção-gestão), Protagonismo (com corresponsabilidade e autonomia).

- **"Acolher não é lugar, é jeito"**.
- **"Ambiência = ambiente + convivência"**.
- **"Referência cuida, matriciamento apoia"**.
- **Diretrizes: "A-G-A-C-V-D"** – Acolhimento, Gestão participativa, Ambiência, Clínica ampliada, Valorização do trabalhador, Defesa dos direitos.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

São princípios da Política Nacional de Humanização:

(A) universalidade, integralidade e equidade.
(B) transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
(C) descentralização, regionalização e hierarquização.
(D) acolhimento, ambiência e clínica ampliada.
(E) hierarquia, disciplina e produtividade.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – são princípios doutrinários do SUS (Lei 8.080/1990).

B) Correta – são os três princípios da PNH.

C) Incorreta – são princípios organizativos do SUS.

D) Incorreta – são diretrizes da PNH, não princípios.

E) Incorreta – não têm relação com a PNH.

QUESTÃO 02

Na perspectiva da PNH, o acolhimento é entendido como:

(A) um espaço físico específico na entrada da unidade.
(B) uma etapa realizada exclusivamente pelo enfermeiro na triagem.
(C) uma postura ética que implica escuta qualificada e reconhecimento das necessidades do usuário, devendo estar presente em todos os momentos do atendimento.
(D) o atendimento por ordem de chegada.
(E) a distribuição de senhas no início do expediente.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – acolhimento não é um local.

B) Incorreta – é responsabilidade de todos os profissionais e não se limita à triagem.

C) Correta – o acolhimento é postura ética, com escuta qualificada e vínculo.

D) Incorreta – com a classificação de risco, o atendimento se dá por gravidade.

E) Incorreta – a distribuição de senhas não caracteriza acolhimento.

QUESTÃO 03

A diretriz da PNH que trata da criação de espaços físicos, sociais e de relações interpessoais saudáveis, acolhedores e que respeitem a privacidade é a:

(A) clínica ampliada.
(B) cogestão.
(C) ambiência.
(D) valorização do trabalhador.
(E) defesa dos direitos dos usuários.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a clínica ampliada considera a singularidade do sujeito no cuidado.

B) Incorreta – a cogestão trata da participação na tomada de decisão.

C) Correta – ambiência é o tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações.

D) Incorreta – a valorização trata do trabalhador e de sua participação.

E) Incorreta – trata do cumprimento dos direitos dos usuários.

QUESTÃO 04

O suporte técnico especializado oferecido por profissionais de diferentes áreas a uma equipe interdisciplinar responsável pelo cuidado de um grupo de usuários é denominado:

(A) equipe de referência.
(B) apoio matricial.
(C) ouvidoria.
(D) colegiado gestor.
(E) visita aberta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a equipe de referência é a responsável direta pelos usuários.

B) Correta – o apoio matricial dá retaguarda especializada às equipes de referência.

C) Incorreta – a ouvidoria é dispositivo de escuta de usuários e trabalhadores.

D) Incorreta – o colegiado é espaço de gestão participativa.

E) Incorreta – a visita aberta amplia o acesso de familiares.

QUESTÃO 05

Sobre a Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de um programa vertical, restrito aos hospitais.

(B) Foi criada em 2010 e se aplica apenas à atenção básica.

(C) É uma política transversal, que deve estar presente em todas as políticas e práticas do SUS, envolvendo usuários, trabalhadores e gestores.

(D) Considera o usuário como receptor passivo das ações de saúde.

(E) Exclui os trabalhadores da tomada de decisões.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a PNH não é programa e não se restringe a hospitais.

B) Incorreta – foi lançada em 2003 e abrange todos os níveis de atenção.

C) Correta – a transversalidade é um de seus princípios, com inclusão dos três sujeitos.

D) Incorreta – a PNH defende o protagonismo e a autonomia do usuário.

E) Incorreta – a valorização e a participação dos trabalhadores são diretrizes.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNH/HumanizaSUS (2003); conceito de humanização; princípios; método da tríplice inclusão; diretrizes (acolhimento, gestão participativa, ambiência, clínica ampliada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos); dispositivos; Carta dos Direitos dos Usuários.

Quadro-resumo: princípios = transversalidade + indissociabilidade + protagonismo; acolhimento = postura ética; ACCR = gravidade; Portaria 1.820/2009 = direitos dos usuários.

Pegadinhas: chamar a PNH de programa; dizer que acolhimento é local ou triagem; confundir princípios do SUS com os da PNH; trocar diretriz por princípio.

Erros comuns: confundir equipe de referência com apoio matricial; achar que a PNH é só para hospitais.